

Ansiedad Social

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es la ansiedad social?

La ansiedad social (también llamada fobia social) es el miedo intenso y persistente a situaciones sociales o de actuación en las que la persona teme ser evaluada negativamente, humillada, rechazada o juzgada por otros.

No es timidez ni introversión. Es un patrón de respuesta ansiosa ante lo social que genera malestar significativo y, frecuentemente, lleva a la evitación de situaciones que deterioran el funcionamiento personal, laboral y relacional.

Situaciones típicamente temidas:

- Hablar en público o frente a grupos
- Iniciar o mantener conversaciones
- Conocer personas nuevas
- Ser observado mientras se come, escribe o trabaja
- Asistir a reuniones sociales o eventos
- Dar su opinión, discrepar o hacer pedidos
- Hacer llamadas telefónicas o interactuar con figuras de autoridad

02. Presentación clínica

Síntomas cognitivos:

- Anticipación de evaluación negativa por parte de los demás
- Creencia de que otros notarán los signos de ansiedad (rubor, voz temblorosa, sudor)
- Procesamiento post-evento: análisis exhaustivo y autocrítico de las interacciones
- Foco atencional interno: hipermonitoreo de las propias respuestas

Síntomas físicos:

- Rubor, sudoración, temblor de voz o manos
- Taquicardia, sensación de ahogo o tensión
- Molestias gastrointestinales en contextos sociales

Síntomas conductuales:

- Evitación activa de situaciones sociales
- Uso de conductas de seguridad: hablar poco, evitar el contacto visual, preparar en exceso
- Consumo de alcohol u otras sustancias para reducir la inhibición social

03. El ciclo de la ansiedad social

Fase	Descripción
Anticipación	Antes del evento: pensamientos sobre lo que puede salir mal, activación fisiológica previa.
Durante la situación	Foco atencional interno, monitoreo de señales de fracaso, respuesta de ansiedad visible o percibida.
Post-evento	Procesamiento rumiativo: análisis de lo dicho y no dicho, magnificación de errores, confirmación de la percepción negativa de uno mismo.
Consecuencia	Refuerzo de la evitación y de la creencia central: "Soy inadecuado/a en lo social".

04. Creencias centrales frecuentes

- "Soy aburrido/a, torpe o inadecuado/a socialmente"
- "Los demás me están juzgando permanentemente"
- "Si muestro ansiedad, los demás me rechazarán"
- "No tengo nada interesante para decir"
- "Cualquier error social tendrá consecuencias graves"

Nota clínica: Las conductas de seguridad (preparar lo que se va a decir, hablar poco, evitar el contacto visual) mantienen estas creencias porque impiden obtener evidencia que las contradiga.

05. Diagnóstico diferencial

Condición	Distinción clave
Timidez / introversión	La timidez no genera malestar clínicamente significativo ni deterioro funcional. La introversión es una preferencia, no un miedo.
Trastorno de pánico	En el pánico, el miedo central es a los síntomas físicos y a perder el control; en ansiedad social, el miedo es a la evaluación negativa de otros.
Trastorno de personalidad evitativa	Comparte características, pero implica un patrón más generalizado de evitación que incluye vínculos cercanos y no solo situaciones de actuación.
Depresión	El aislamiento social en depresión es consecuencia de la anhedonia y el agotamiento, no del miedo a la evaluación.

06. Tratamiento

La terapia cognitivo-conductual es el tratamiento con mayor evidencia para la ansiedad social:

- Psicoeducación sobre el ciclo de la ansiedad social
- Reestructuración cognitiva: cuestionamiento de creencias sobre la evaluación social
- Reducción del foco atencional interno y del procesamiento post-evento
- Exposición gradual a situaciones temidas con reducción de conductas de seguridad
- Entrenamiento en habilidades sociales cuando hay déficits reales
- Mindfulness para reducir el automonitoreo durante la interacción